

Indywidualny program zabiegów fizykalnych

Przypadek kliniczny: pacjent z zespołem cieśni nadgarstka

Opracowanie indywidualnego programu w ramach balneoterapii i odnowy biologicznej

Imię i nazwisko • kierunek studiów • rok akademicki



Plan prezentacji

1. Charakterystyka pacjenta

2. Analiza wskazań i przeciwwskazań

3. Dobór zabiegów fizykalnych

4. Opracowanie programu terapii

5. Efekty terapeutyczne

6. Elementy odnowy biologicznej

7. Podsumowanie i wnioski

8. Bibliografia

Charakterystyka pacjenta

Dane podstawowe, tryb życia i rozpoznanie

Dane podstawowe

Wiek:

39 lat

Płeć:

mężczyzna

Zawód:

informatyk

Praca:

ponad 8 h dziennie przy komputerze

Tryb życia:

siedzący, niska aktywność fizyczna

Rozpoznanie

- Zespół cieśni nadgarstka (ucisk nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka) prawej ręki.

Dolegliwości i ograniczenia funkcjonalne

- Drętwienie i mrowienie palców prawej dłoni.
- Nasilenie objawów w nocy oraz podczas pracy przy klawiaturze.
- Ból nadgarstka, osłabienie siły chwytu.
- Trudności w wykonywaniu precyzyjnych czynności manualnych.
- Przeciążenie wynikające z monotonnej, statycznej pozycji.

Analiza wskazań

Wskazania do zastosowania zabiegów fizykalnych

- Zespół cieśni nadgarstka o łagodnym / umiarkowanym nasileniu (bez wskazań do leczenia operacyjnego).
- Dolegliwości bólowe i parestezje (drętwienie, mrowienie).
- Stan przeciążeniowy ścięgien i pochewek w okolicy nadgarstka.
- Osłabienie siły mięśniowej i obniżona sprawność manualna ręki.
- Przewlekłe napięcie mięśniowe obręczy barkowej i przedramienia wynikające z pracy siedzącej.
- Profilaktyka wtórna – zapobieganie nawrotom i progresji objawów.

Uzasadnienie wyboru metod

Metody fizykalne działają przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo, poprawiają ukrwienie oraz zmniejszają ucisk na nerw pośrodkowy – są leczeniem zachowawczym pierwszego wyboru.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania ogólne i miejscowe

Przeciwwskazania ogólne

- Choroba nowotworowa (czynna).
- Stany gorączkowe i ostre infekcje.
- Niewydolność krążenia i ciężkie choroby serca.
- Skłonność do krwawień, leczenie przeciwkrzepliwe.
- Cięża (dla wybranych zabiegów).
- Rozrusznik serca (zabiegi elektro- i magnetoterapii).

Przeciwwskazania miejscowe

- Ostry stan zapalny i obrzęk w okolicy nadgarstka.
- Uszkodzenia i zmiany skórne, rany, infekcje skóry.
- Świeży uraz, złamanie w obrębie ręki.
- Zaawansowany zanik mięśni kłędu kciuka (wskazanie do konsultacji chirurgicznej).
- Zakrzepica żył kończyny.

Dobór zabiegów fizykalnych (1/2)

Balneoterapia, hydroterapia i zabiegi cieplne

Zabieg	Mechanizm działania	Cel terapeutyczny
Kąpiele solankowe / borowinowe ręki	Działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, poprawa ukrwienia tkanek.	Zmniejszenie obrzęku i ucisku na nerw pośrodkowy.
Kąpiel wirowa kończyny górnej	Delikatny masaż wodny + ciepło – rozluźnienie i lepsze krążenie.	Redukcja napięcia mięśni przedramienia, poprawa trofiki.
Okłady borowinowe (zawijania)	Głębokie, długotrwałe przegrzanie + składniki biologicznie czynne.	Działanie przeciwzapalne i regenerujące tkanki okołostawowe.
Kąpiele naprzemienne (cieplno-zimne)	Naprzemienne rozszerzanie i obkurczanie naczyń – „gimnastyka naczyń”.	Poprawa mikrokrażenia, zmniejszenie zastoju i obrzęku.

Dobór zabiegów fizykalnych (2/2)

Fizykoterapia, masaż i kinezyterapia

Zabieg	Mechanizm działania	Cel terapeutyczny
Krioterapia miejscowa	Krótkotrwałe schłodzenie – efekt przeciwbólowy i przeciwobrzękowy.	Ograniczenie stanu zapalnego pochewek ścięgniastych.
Ultradźwięki / fonoforeza	Mikromasaż tkankowy, działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.	Zmniejszenie dolegliwości w obrębie kanału nadgarstka.
Laseroterapia / magnetoterapia	Stymulacja regeneracji nerwu, działanie przeciwzapalne.	Poprawa przewodnictwa nerwowego, redukcja parestezji.
Masaż przedramienia i obręczy barkowej	Rozluźnienie mięśni, poprawa krążenia i drenażu.	Zmniejszenie napięcia i przeciążeń wtórnych.
Kinezyterapia – ćwiczenia ślizgowe nerwu	Mobilizacja nerwu i ścięgien, ćwiczenia wzmacniające.	Poprawa ruchomości, siły chwytu i sprawności ręki.

4

Opracowanie programu terapii

Przykładowy plan tygodniowy (cykl 3 tygodni / 15 zabiegów)

Pon.	Wt.	Śr.	Czw.	Pt.
Kąpiel wirowa ręki (15 min) Ultradźwięki (5 min) Ćwiczenia ślizgowe nerwu	Okład borowinowy (20 min) Magnetoterapia (15 min)	Kąpiel solankowa (15 min) Masaż przedramienia (15 min)	Laseroterapia Kinezyterapia – wzmacnianie Ćwiczenia rozciągające	Kąpiele naprzemienne Krioterapia (w razie bólu) Relaksacja

Zasady realizacji programu

- Częstotliwość: 5 dni w tygodniu; weekend – odpoczynek i autoterapia (ćwiczenia, higiena pracy). Czas serii: ok. 3 tygodnie (15 zabiegów).
- Kolejność: zabiegi ciepłe / rozluźniające → terapia właściwa → kinezyterapia. Intensywność dostosowana do reakcji i stanu pacjenta.

Efekty terapeutyczne

Przewidywane rezultaty zastosowanej terapii

Zmniejszenie bólu

Redukcja dolegliwości bólowych nadgarstka i parestezji (drętwienia, mrowienia) palców.

Lepsze ukrwienie

Poprawa mikrokrażenia i trofiki tkanek, zmniejszenie obrzęku i ucisku na nerw pośrodkowy.

Większa sprawność

Wzrost siły chwytu i precyzji ruchów, poprawa zakresu ruchomości nadgarstka.

Rozluźnienie

Zmniejszenie napięcia mięśni przedramienia i obręczy barkowej, ustąpienie przeciążeń.

Lepszy sen

Ograniczenie nocnych dolegliwości bólowych poprawia jakość snu i regenerację.

Lepsze samopoczucie

Ogólna regeneracja, redukcja stresu i poprawa komfortu pracy oraz życia.

6

Elementy odnowy biologicznej

Dodatkowe formy regeneracji i ich znaczenie

1

Ergonomia i higiena pracy

Prawidłowe ustawienie stanowiska, podkładka pod nadgarstek, regularne przerwy i mikroćwiczenia co 45–60 min.

2

Aktywność fizyczna

Regularny ruch (pływanie, spacer), ćwiczenia ogólnousprawniające – przeciwdziałanie skutkom siedzącego trybu życia.

3

Techniki relaksacyjne

Trening relaksacyjny, ćwiczenia oddechowe i rozciągające – redukcja napięcia mięśniowego i stresu.

4

Dieta i nawodnienie

Dieta przeciwzapalna, bogata w wit. z grupy B; odpowiednie nawodnienie wspiera regenerację tkanki nerwowej.

5

Higiena snu i odpoczynek

Regularny sen, unikanie spania z mocno zgiętym nadgarstkiem, orteza nocna stabilizująca rękę.

6

Edukacja zdrowotna

Świadomość czynników ryzyka i profilaktyka nawrotów – warunek trwałości efektów terapii.

Podsumowanie i wnioski

Ocena skuteczności i możliwości modyfikacji terapii

Ocena skuteczności programu

- Kompleksowe leczenie zachowawcze (balneoterapia + fizykoterapia + kinezyterapia + odnowa biologiczna) skutecznie zmniejsza objawy łagodnego i umiarkowanego zespołu cieśni nadgarstka.
- Połączenie zabiegów miejscowych z modyfikacją stylu życia i ergonomii pracy daje trwalsze efekty niż samo leczenie objawowe.
- Wczesne wdrożenie terapii zmniejsza ryzyko progresji i potrzeby leczenia operacyjnego.

Możliwości modyfikacji terapii

- Program należy monitorować i dostosowywać do reakcji oraz postępów pacjenta (intensywność, dobór i liczba zabiegów).
- Brak poprawy lub nasilenie objawów / zanik mięśni → konsultacja neurologiczna i chirurgiczna (EMG, ewentualne leczenie operacyjne).

Literatura podstawowa

- Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A.: Medycyna fizykalna. PZWL, Warszawa 2000.
- Ponikowska I., Ferson D.: Nowoczesna Medycyna Uzdrowiskowa. Medi Press, Warszawa 2009.
- Kasprzak W.: Fizjoterapia kliniczna. PZWL, Warszawa 2011.
- Kasprzak W., Mańkowska A.: Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA. PZWL, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

- Ponikowska J.: Kompendium balneologii: rekomendacje krajowego konsultanta. Toruń 2012.
- Kochański J. W.: Balneologia i hydroterapia. Wydawnictwo AWF, Wrocław 2002.

Dziękuję za uwagę

Indywidualny program zabiegów fizykalnych – zespół cieśni nadgarstka